

CAPÍTULO 12.1

Demencia y Delirium

PERFIL EUNACOM 1.10.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Demencia y Delirium

Diferencia Fundamental

TABLA 12.1.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	DEMENCIA	DELIRIUM
Alteración principal	Memoria (corto plazo)	Atención
Instalación	Crónica (meses/años)	Aguda (horas/días)
Curso	Progresivo, estable	Fluctuante (peor al anochecer)
Causa	Degenerativa (habitualmente)	Tóxico-metabólica (infección, fármacos, etc.)
Compromiso de conciencia	No (al inicio)	Sí (cuantitativo o cualitativo)
Tratamiento	Ambulatorio	Hospitalización + buscar causa

Demencias

Diagnóstico

- **Clínico** (anamnesis + examen físico)
- **Mini-mental (MMSE):** < 24/30 puntos → probable demencia
- **Test del reloj:** dibuja un reloj incorrecto (empieza por 1, 2, 3 en vez de ubicar 12 arriba)
- **Exámenes mínimos obligatorios:**
 - - TSH (hipotiroidismo)
 - - VDRL + VIH (neurosífilis, demencia por VIH)
 - - Vitamina B12
 - - **TAC cerebro** (hidrocefalia, tumor, AVC)
 - - Hemograma, función renal/hepática, electrolitos

Tipos de Demencia — Clínica Diferenciadora

TABLA 12.1.2: TIPO VS CLAVE CLÍNICA		
TIPO	CLAVE CLÍNICA	HALLAZGO
Alzheimer	Más frecuente; inicio insidioso; olvidos + apraxias + agnosias	TAC: atrofia difusa
Vascular	Segunda más frecuente; antecedente de AVC; hemiparesia + demencia	TAC: lesiones vasculares
Frontotemporal (Pick)	Jóvenes (50–60 años); desinhibición , conducta inapropiada; avance rápido	TAC: atrofia frontotemporal
Cuerpos de Lewy	Demencia + síntomas extrapiramidales + alucinaciones visuales complejas	Antipsicóticos contraindicados
Hidrocefalia normotensiva	Tríada: demencia + caídas (marcha anormal) + incontinencia urinaria	TAC: hidrocefalia sin hipertensión
VIH	Demencia de instalación rápida en paciente joven	—

EUNACOM CRITERIOS

Tríada hidrocefalia normotensiva: demencia + caídas + incontinencia urinaria. Tratable con válvula de derivación ventriculoperitoneal → descartar siempre con TAC.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cuerpos de Lewy + antipsicóticos = contraindicado. Los antipsicóticos son antidopaminérgicos → empeoran los síntomas extrapiramidales y la demencia.

Tratamiento

- **Multidisciplinario** (médico + psicólogo + terapeuta ocupacional + geriatra)
- Apoyar al cuidador (riesgo de depresión del cuidador)
- **Fármacos** (etapas iniciales):
 - - **Donepezilo** (inhibidor acetilcolinesterasa) — de elección
 - - Rivastigmina (alternativa)
 - - Memantina (complemento en etapas moderadas-graves)

Delirium (Síndrome Confusional Agudo)

Criterios CAM (Confusional Assessment Method)

- Para diagnosticar delirium deben cumplirse:
- **Inatención** (siempre obligatorio)
- **Inicio agudo** (siempre obligatorio)
- **Curso fluctuante** O **compromiso de conciencia**

Causas (cualquier alteración tóxico-metabólica)

- Infecciones (lo más frecuente): neumonía, ITU, bacteriemia
- Fármacos (benzodiazepinas, anticolinérgicos, opioides)
- Alteraciones metabólicas: hiponatremia, hipoglicemia, falla hepática/renal
- AVC, infarto al miocardio

Evaluación de la atención

- Pedir que enumere días de la semana al revés: **domingo, sábado...**
- Si lo hace bien, intentar algo más difícil

Tratamiento

- **Hospitalizar** + buscar y tratar la **causa**
- **Medidas generales** (lo más eficaz):
 - - Orientar al paciente (decirle dónde está, quién es el médico, fecha)
 - - Que use sus lentes y audífonos
 - - **Ejercicio durante el día** (evita agitación nocturna)
- **Antipsicóticos** en dosis bajas si hay agitación intensa:
 - - **Haloperidol 0,5–1 mg IM** (de elección)
 - - Risperidona (alternativa)
 - - **NUNCA benzodiazepinas** (empeoran el delirium)

NOTA CLÍNICA

El delirium empeora al anochecer (sundowning). La mejor medida preventiva es mantener al paciente activo y despierto durante el día con ejercicio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 80 años es traído por familiares por cuadro de 2 días de evolución de desorientación, agitación psicomotora nocturna y alucinaciones visuales. Tiene antecedente de infección urinaria en tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Demencia y Delirium. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Demencia = alteración de memoria (especialmente corto plazo) + apraxias + agnosias, curso crónico. Delirium = alteración de atención + compromiso de conciencia, inicio agudo.
- Diagnóstico de ambos es clínico. Demencia: Mini-Mental (<24/30) y test del reloj. Delirium: CAM (inatención + inicio agudo + curso fluctuante o compromiso de conciencia).
- Causas de delirium: cualquier alteración tóxico-metabólica (infecciones lo más frecuente sin medicamentos, medicamentos lo más frecuente en general).
- Estudio mínimo de demencia: TSH, VDRL, VIH, vitamina B12, TAC, exámenes generales. Objetivo: descartar causas tratables.
- Tratamiento demencia: multidisciplinario + evitar estrés del cuidador + donepesilo (inhibidor acetilcolinesterasa, de elección) o memantina.
- Tratamiento delirium: hospitalizar + medidas generales (reorientación, lentes, audífonos, ejercicio) + haloperidol 0.5-1 mg + tratar la causa.
- Alzheimer: causa más frecuente de demencia. Frontotemporal (Pick): desinhibición en paciente más joven. Vascular: segunda causa, post-AVE.
- Hidrocefalia normotensiva: tríada demencia + caídas + incontinencia. Tratable con válvula de derivación ventrículo-peritoneal.
- Demencia por cuerpos de Lewy: demencia + extrapiramidal + alucinaciones complejas. Antipsicóticos CONTRAINDICADOS.
- El delirium es una urgencia que se hospitaliza; la demencia se maneja ambulatoriamente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DEMENCIA Y DELIRIUM)**PREGUNTA 1**

Paciente de 80 años es traído por familiares por cuadro de 2 días de evolución de desorientación, agitación psicomotora nocturna y alucinaciones visuales. Tiene antecedente de infección urinaria en tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Enfermedad de Alzheimer descompensada
- B)** Delirium o síndrome confusional agudo
- C)** Demencia por cuerpos de Lewy
- D)** Trastorno psicótico agudo
- E)** Demencia frontotemporal

PREGUNTA 2

Paciente de 68 años consulta por deterioro cognitivo progresivo de 4 meses, múltiples caídas por torpeza motora e incontinencia urinaria de inicio reciente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Iniciar donepesilo por probable Alzheimer
- B)** Solicitar TAC de cerebro
- C)** Derivar a psiquiatría por probable depresión del adulto mayor
- D)** Solicitar electroencefalograma
- E)** Indicar haloperidol 0.5 mg por probable delirium

PREGUNTA 3

Paciente de 72 años con diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy presenta agitación psicomotora importante. ¿Cuál de los siguientes fármacos está CONTRAINDICADO?

- A)** Donepesilo
- B)** Memantina
- C)** Haloperidol
- D)** Rivastigmina
- E)** Lorazepam

RESUMEN: DEMENCIA Y DELIRIUM

Esta clase aborda dos temas fundamentales en neurología y geriatría: la demencia y el delirium. Se establece un paralelo claro entre ambos cuadros. La demencia se caracteriza por alteración de la memoria (especialmente a corto plazo), acompañada de apraxias y agnosias, con un curso crónico y progresivo de meses a años, causada principalmente por enfermedades degenerativas. El delirium, en cambio, se define por alteración de la atención, compromiso de conciencia (cualitativo o cuantitativo), inicio agudo y curso fluctuante, causado por alteraciones tóxico-metabólicas como infecciones o medicamentos. El diagnóstico de ambos es clínico. Para la demencia se utiliza el Mini-Mental (menos de 24/30 puntos sugiere demencia) y el test del reloj. Para el delirium se usa el CAM (Confusional Assessment Method), que requiere inatención, inicio agudo, y curso fluctuante o compromiso de conciencia. El estudio de la demencia incluye TSH, VDRL, VIH, vitamina B12, TAC y exámenes generales para descartar causas tratables. El delirium requiere hospitalización con múltiples exámenes buscando la causa. El tratamiento de la demencia es multidisciplinario, incluyendo evitar el estrés del cuidador y fármacos como donepesilo (inhibidor de acetilcolinesterasa) o memantina. El delirium se maneja con medidas generales (reorientación, lentes, audífonos, ejercicio diurno), antipsicóticos en dosis bajas (haloperidol 0.5-1 mg) y tratamiento de la causa. Se revisan casos específicos: Alzheimer (demencia sin más clínica, la más frecuente), demencia frontotemporal o de Pick (desinhibición en paciente más joven), demencia vascular (post-AVE, segunda causa más frecuente), hidrocefalia normotensiva (triada de demencia, caídas e incontinencia, tratable con válvula de derivación), demencia por cuerpos de Lewy (demencia más síntomas extrapiramidales más alucinaciones complejas, contraindicados los antipsicóticos), y un caso de delirium en paciente con demencia de base.